EPICRISIS CMA

Servicio U.E.A.P.
Plan Esp:
Ingreso N° : **244365**
Fecha de ingreso lunes, 15 enero, 2024
Fecha de egreso lunes, 15 enero, 2024

Datos del Paciente:

Nombre del Paciente: RUTH EUGENIA GONZALEZ POBLETE **Edad** 54 años
Cta. Cte N°: 758837502 **RUT:** 11444493 **Ficha Clínica N°** 2007329638
Prevision: FONASA B **Tipo Interv.:** **Tipo Paciente:** Ambulatorio
Diag. Ingreso LUXACION CADERA D
Diag. Egreso LUXACION CADERA D
Interv. Prog.: 21.04.133 Luxación traumática de cadera. Reducción cruenta

Equipo Quirúrgico:

Cirujano: Ricardo Rebolledo Rebolledo **Ayudante(s):**
Anestesista: Cristobal Legassa Artigas
Arsenalera: Patricia Osorio

Datos del Acto Quirúgico:

Hora Inicio: 22:48 *hrs.* **Hora Termino:** 22:55 *hrs.* **Duración:** 00:07 *hrs.* **Quirófano:** 8
Tipo Herida: Sin Herida Op. **Tipo Anestesia:** General EV/Inhalatoria **Tipo Cirugía** Urgencia
Transfusion: **Hemoderivado** **Cantidad:** 0 *c.c.*
Muestra(s) Organica(s) **Profilaxis** Antibiótica
Tromboembolismo
Riesgo de Tromboembolismo: Bajo

Intervención(es) Realizada(s):

21.07.002 Luxaciones de articulaciones mayores (Cadera, columna)

Indicaciones Postoperatorias:

1.- A recuperación
2.- Reposo en cama, extremidad en abducción y rotación externa
3.- Régimen cero por 4 hrs luego realimentar
4.- SF 0,9% 500cc + Metamizol 2gr + Ketoprofeno 100mg a 20cc/hora
5.- Traslado de regreso a hospital de origen (San Carlos) al alta de recuperación.

Comentarios de egreso:

1.- Hospitalizar en San Carlos
2.- Reposo en cama, extremidad abduccion y rotación externa
3.- Régimen hiposódico
4.- Analgesia
5.- Gastroprotección
6.- Tromboprofilaxis
7.- Fármacos de uso crónico de manera habitual
8.- Control por equipo TMT HSC; considerar uso de inmovilizador de cadera
9.- Control CAE Traumatología en 3 semanas con equipo de cadera (López, Pavez, Ortiz o Gutierrez). Gestionar hora vía correo con Paula Kulhmann, CMA.

Epicrisis Registrada por: Ricardo Rebolledo Rebolledo

Firma